

Łagodne *eksperymenty*

Nie konfrontujemy urojeń. Razem z terapeutą sprawdzamy, czy istnieją inne wyjaśnienia. Pacjent SAM dochodzi do wniosku — to dlatego zmiana trwa.

CZAS: 30-45 min na eksperyment Po stabilizacji · z terapeutą

ŹRÓDŁO: Chadwick & Lowe (1990); Morrison (2017); Garety i in. (2008); Bennett-Levy (2004)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedno przekonanie** o niskim/średnim natężeniu (sekcja 1), zaplanuj eksperyment w 5 krokach (sekcja 2), wykonaj go i opisz wynik (sekcja 3). Cel: *nowa informacja*, nie „dowód, że nie miałem racji”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bezpośrednia konfrontacja urojeń („*to nieprawda, nikt Pana nie śledzi*”) prawie nigdy nie działa — wywołuje opór, zerwanie sojuszu, dropout. Chadwick & Lowe (1990) pokazali, że **delikatne testowanie** w atmosferze ciekawości — „*sprawdźmy razem*” — pozwala pacjentowi *samemu* dojść do alternatywnych wniosków. Garety i in. (2008): zmiana wynikająca z własnego odkrycia trwa dłużej niż zmiana narzucona.

01 ☉ Wybór przekonania do testowania

Nie zaczynaj od przekonania, w które wierzysz **100%** — łatwiej z czymś, w co wierzysz w 50-70%. Niskie/średnie przekonanie (ang. *low conviction*) to dobre miejsce na początek. Wybierz coś, co jest **konkretne** (da się sprawdzić) i co **boli** (warto się z tym zmierzyć).

CO NIE NADAJE SIĘ JESZCZE

Przekonania z *conviction* = 10 i wysokim ryzykiem dla bezpieczeństwa. Urojenia, które aktualnie powodują działania ochronne. Pełna psychoza w fazie ostrej. Tu najpierw stabilizacja.

CO NADAJE SIĘ

Przekonanie sprawdzalne („*sąsiad mnie obserwuje*”, „*ludzie na ulicy patrzą na mnie z dezaprobatą*”). Średnie *conviction* (3-7). Pacjent gotowy testować, otwarty na nową informację.

02 → Pięć kroków eksperymentu

KROK 1 · SFORMUŁUJ PRZEKONANIE PRECYZYJNIE

Nie „*ludzie mnie obserwują*”, tylko „*w autobusie linii 6 między 8:00 a 8:30 co najmniej 3 osoby patrzą na mnie z wrogą intencją*”. Im precyzyjniej, tym łatwiej zweryfikować.

KROK 2 · CO BY ŚWIADCZYŁO ZA, CO PRZECIW?

Lista za (3-5 pozycji) i przeciw (3-5 pozycji). Wspólnie z terapeutą — sam fakt napisania alternatyw często obniża *conviction*.

KROK 3 · KONKRETNY TEST

„*Pojadę autobusem linii 6 jutro o 8:15 i policzę osoby patrzące na mnie*”. Dane, nie wrażenie. Jeśli za trudne — najpierw *na sucho*, jak hipotetycznie test mógłby wyglądać.

KROK 4 · WYKONAJ — Z TOWARZYSZEM

Najpierw z terapeutą obok, potem z bliską osobą. Zapisz obserwacje **w trakcie** — pamięć po jest zniekształcona przez emocje.

KROK 5 · REFLEKSJA — CO TO ZMIENIA?

Nie „*miałem rację*” lub „*nie*”. Pytaj: „*co nowego się dowiedziałem?*” Cel: *nowa informacja*, nie ostateczny dowód.

03 Mój eksperyment

1 · PRZEKONANIE PRECYZYJNIE

— kiedy, gdzie, kto, jak

2A · DOWODY ZA

— co przemawia za przekonaniem

2B · DOWODY PRZECIW

— co przemawia przeciw, alternatywne wyjaśnienia

3 · PLAN EKSPERYMENTU

— co zrobić, kiedy, z kim

4 · CO ZAOBSERWOWAŁEM/-AM

— fakty z eksperymentu

5 · CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁEM/-AM

— nowa informacja, nowe pytania

04 Conviction — przed i po eksperymencie

Zaznacz **przekonanie** (ang. *conviction*) bezpośrednio przed eksperymentem i godzinę po jego zakończeniu. Pamiętaj — celem **nie** jest spadek do zera, lecz *uchylenie* pewności na tyle, by powstała przestrzeń na inne wyjaśnienia.

Conviction *nie*
— **przed** *wierzę* (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

*pełna
pewność*

Conviction *nie*
— **po** *wierzę* (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

*pełna
pewność*

Klucz: Garety i in. (2008) wykazali, że **zmiana w pamięci epizodycznej** (konkretne wspomnienie eksperymentu) jest skuteczniejsza niż *zmiana w ogólnej teorii* (przekonania abstrakcyjne). Dlatego CBTp opiera się na **konkretach**: jedno przekonanie, jeden eksperyment, jedna obserwacja. Powtarzanie buduje dowody alternatywne. Morrison (2017): „*nie zwalczamy urojeń — pomagamy mózgowi zebrać nowe dane*”. Cel pacjenta: nie „*mam rację, że nie mam racji*”, lecz *otwartość na inne wyjaśnienia*.